EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 83251
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 25-04-2024

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: EDITA GUADALUPE LOPEZ TORRES			RUN	: 6.452.585-9
F.Nac	: 07-07-1948	Edad	: 75 AÑOS, 9 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: MONTE BLANCO			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 965149353		
Fecha Ingreso	: 2024-04-23	Fecha Egreso	: 25-04-2024	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Insuficiencia Respiratoria Aguda
1.1 Neumonía basal derecha
1.2 Insuficiencia Cardiaca Descompensada
1.3. EPOC GOLD 4 grupo E exacerbado
2. Acidosis respiratoria primaria con alcalosis metabólica secundaria compensada
3. FA cRVR

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. J44.9-ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO ESPECIFICADA (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)
2. I10-HIPERTENSION ESENCIAL(PRIMARIA) (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
3. I50-INSUFICIENCIA CARDIACA (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)
4. I48-FIBRILACION Y ALETEO AURICULAR (DIAGNÓSTICO SECUNDARIO)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de HTA, DMT2 NIR, FA RVA, IC FEVI conservada (57%) en Tratamiento DOAC, EPOC GOLD 4 Grupo E en tratamiento, con cuadro pulmonar de larga data asociado a descompensaciones previas que requirieron hospitalización (ultima 2023), consulta por cuadro de 3 dias de evolución caracterizado por disnea progresiva que empeora durante la noche y no cede a broncodilatacion crónica, refiere similar a episodios anteriores pero esta vez paciente niega tos, expectoración, fiebre. Refiere control en medico broncopulmonar e internista, con o2 domiciliario suspendido por buena respuesta a ajuste de tratamiento. Al Ingreso SU, taquipneica, hipertensa, afebril, taquicardica, Sat 68%, Diaforetica, con uso de musculatura accs. Paciente en el SU, se apoya con oxigeno, NBZ, corticoide y terapia depletiva, se logra titular a 2 lt NRC con adecuada tolerancia, actualmente leve disnea, normotensa, normocardica, sin uso de musculatura accesoria, con mecanica regular, Saturacion en rango (92%). Durante estancia en servicio de urgencias presenta episodio de FA cRVR con FC alcanzado aprox 170lpm, requiriendo cardioversión farmacológica con Lanatósido C + Verapamilo 2.5mg + Propanolol 1mg ev. Paciente hospitalizada en contexto de insuficiencia respiratoria aguda secundario a componente mixto. se evidencia un alza de parametros inflamatorios al ingreso por lo que se solicita panel viral de resultado negativo y cultivo de secrecines aun pendiente, recibe tratamiento antibiotico con ceftriaxona EV actualmente en su dia 2, mas terapia depletiva y terapia broncodilatadora, paciente evoluciona en favorables condiciones, estable desde el punto de vista hemodinamico, sin requerimiento de oxígeno actual. no refiere dolor torácico, ni disnea actual, kinesioterapia bien tolerada, parametros inflamatorios a la baja, dada evolucion favorable, se decide alta medica con continuidad de terapia antibiotica EV por HODOM y control con gases art en 48 horas.

PLAN DE MANEJO:

- Continuar terapia antibiotica EV, Ceftriaxona hasta completar 7 dias actualmente en dia 2/7 en HODOM, se añade nitrofurantoina a terapia VO
- Desde el punto de vista respiratorio paciente con EPOC GOLD 4, Debe continuar su terapia cronica con inhaladores + kinesioterapia respiratoria interdiaria por HODOM, se realizara control de laboratorios y gases venosos en 48 horas
- Rescatar resultado de cultivo de secrecion
- Pendiente ecocardiograma ambulatorio solicitado.

INDICACIONES AL ALTA

1. -Reposo Relativo asistido Seguimiento en HODOM
2. -Régimen diabético, hiposódico
3. -KNT respiratoria interdiaria en HODOM
4. -Ceftriaxona 2gr ev día por 5 dias hasta completar 7 dias 2/7
5. -Nitofurantoina 100mg c/8 hrs VO por 7 dias
6. -Omeprazol 20mg vo dia
7. -Bisoprolol 2.5 mg vo cada 24 hrs
8. -Dabigatran 150mg vo c/12 hrs
9. -Espironolactona 25mg vo c/dia
10. -Furosemida 40mg vo c/dia
11. -Diltiazem 60mg vo c/8 hrs
12. -brexotide 2 puff cada 12 hrs por AEC
13. -ipratropio 4 puff cada 6 hrs por AEC
14. -salbutamol 2 puff cada 8 hrs por AEC
15. -Trelegy 1 puff dia
16. -Ecocardiograma ambulatorio
17. -Control ex lab en 48 horas (gases, hemograma y bioquimico)
18. -Acudir a Urgencias SOS

EXÁMENES Y RESULTADOS

Creatinina: 0.70 mg/dl | Clearence Calculado (MDRD): 81.58 ml/min/1.73 | Uremia: 71 mg/dl | Nitrógeno Ureico (BUN): 33 mg/dL | Sodio (Na): 143.00 mmol/L | Potasio (K): 3.30 mmol/L | Cloro (Cl): 97.00 mmol/L | Recuento de Leucocitos: 17.00 mil/ul | Recuento de Hematíes: 5.19 Mill/ul | Hematocrito: 45.4% | Hemoglobina: 14.9 g/dl | Volumen Corpuscular Medio (VCM): 87.4 fl | Hemoglobina Corpuscular Media (HCM): 28.7 ug | Concentración de Hemoglobina Corpuscular Media (CHCM): 32.8 g/dL | Ancho de Distribución Eritrocitaria (RDW): 14.7% | Plaquetas: 160 mil/ul | Segmentados: 82% | Linfocitos: 10% | Monocitos: 3% | Eosinófilos: 2% | Basófilos: 1% | Baciliformes: 2.0% | VHS: 20 | NT-proBNP: 2901 pg/mL | pH: 7.47 | pCO2: 53.0 mmHg | pO2: 64.2 mmHg | HCO3 ACT.: 39.3 mmol/L | BE (B): 13.3 mmol/L | O2 SAT: 89.0% | A-aDO2: 18.7.
Panel Viral: negativo

OBSERVACIONES:

Dr. Andres Velasquez
Int. Cristian Perez

Control en: 14 días en HOSPITAL DE SAN CARLOS

andres david velasquez guerra
MEDICO TRATANTE
27124399-5

JEFE SERVICIO